EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 83513
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-30 08:57:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: TEMISTOCLES SEPULVEDA SEPULVEDA			RUN	: 7.859.748-8
F.Nac	: 11-04-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-11	Fecha Egreso	: 2024-04-30 08:57:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G61.0-SINDROME DE GUILLAIN-BARRE

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Tetraparesia hiperaguda hipotónica/arrefléctica -> EMG+ AMAN (variante axonal)
- Antecedente de sd diarreico días previos
- LCR disociación albúmino citológica
- sin compromiso sensitivo /esfinter

2. DM2 IR de reciente diagnóstico
3. Discopatía degenerativa sin compromiso de canal raquídeo
- RM columna cervico dorsal no se logra realizar por dolor en EE/falta cooperación

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G61.0-SINDROME DE GUILLAIN-BARRE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

mRS 0, vive solo, con buena red apoyo familiar, consulta el 10.04.24 tras despertar con dificultad para caminar y movilizar 4 extremidades, al interrogatorio dirigido presentó 10 días antes cuadro diarreico autolimitado, sin antecedente de vacunación reciente, al examen neurológico de ingreso destacaba mental normal, PC conservados, EESS M3- distal/M3+ proximal bilateral, arrefléctico, hipotónico, en EEIII M2 distal, M3- proximal, rot abolidos, tono disminuido, plantares flexores, no se logra evidenciar nivel sensitivo, llama la atención globo vesical que presenta solo en ingreso, posteriormente sin compromiso esfinteriano, TC cerebro-columna completa destaca cambios degenerativos en columna cervico-dorsal sin compromiso de canal raquídeo, LCR con disociación albúmino-citológica, se plantea sospecha Sd. Guillain Barré, se notifica, se indica hospitalizar inicialmente en UCI por rapidez de cuadro clínico, completando sin incidentes Inmunoglobulinas (34,4 gr x día x 5 días) . El 13.04.24 Dra. Ruf (sub-especialista en periférico HCHM) realiza Electromiografía y velocidad de conducción de 4 extremidades con evidencia de severa poliradiculoneuropatia aguda, motora, con características axonales, no largo dependiente, sugerente de AMAN, sin compromiso de fibras sensitivas. Paciente evoluciona al 3er días con tetraplejia hipotónica, arrefléctica, sin compromiso significativo de PC, sin disautonomías, sin dolor, sin embargo, durante hospitalización comienza mejoría lenta pero progresiva, sin conflicto ventilatorio ni infeccioso, con control de esfínter, al examen neurológico de hoy EESS M2- proximal/M3+ distal derecho, M2- proximal/M2+ distal izquierdo, en EEIII M3 proximal, M2+ distal, rot abolidos en 4 extremidades, hipotónico, plantares flexores, sin compromiso sensitivo. Por estabilidad clínica, con plan de rehabilitación kinésica ambulatoria, indico HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo rleativo, sentar asistido, evitar ulceras por presión, movilización frecuente
2. 2. Régimen diabético liviano

3. 3. losartan 50 mg vo dia
4. 4. gemfibrozilo 600 mg vo c/12 hrs
5. 5. Sertralina 50 mg x 2 vo am
6. 6. PEG 1 sobre vo cada 2-3 días
7. 7. insulina NPH 22 U am/ 16 U pm sc
8. 8. pregabalina 75 mg vo c/12 hrs
9. 9. Kinesiología + TO ambulatorio al alta
10. 10. HODOM -> priorizar rehabilitación
11. 11. al alta control poli neurología en 10 días

EXÁMENES Y RESULTADOS

LCR transparente, incoloro, glucosa 124 (HGT 230), proteínas 94 mg/dl, leucocitos <5, gtam no se observan microorganismos, cultivo negativo
serologia VHB VHC negativo
VIH /RPR no reactivo
AntiDNA,, ANA, C3-C4, perfil ENA negativos
Vitamina B12 365 (N), TSH 2,4
Hemoglobina glicosilada 8,6%
Laboratorio 12.04.24 :Hto 46,9%, leucocitos 8800, plaquetas 226.000, PCR 18,9, Crea 0,8, Na+ 133, K+ 4,5, Cl- 100, GA seriados Normales, INR 1,09
Col total 218, TG 518

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO